Auscultación pulmonar, broncoespasmo y asma

SEMIOLOGIA · Clase 16 · murmullo, sibilancias, frote y voz; el caso del asma

1 · CÓMO SE AUSCULTA

Técnica
paciente sentado, boca entreabierta, respiración lenta y mediana; diafragma firme, de arriba abajo y comparando con el lado homólogo

se recorre → **Qué se recorre**
cara posterior, anterior y fosas supraclaviculares; al final, la voz con «33»
asegura el recorrido → Sentado, de arriba abajo y lado contra lado: así se recorre todo el pulmón sin perder los ápices ni crear ruidos falsos

ante un ruido dudoso → **Ruido dudoso**
pedir respirar hondo y toser
no se pide si hay → **No se pide** si hay dolor intenso, disnea acentuada o hemoptisis
asegura el recorrido → Sentado, de arriba abajo y lado contra lado: así se recorre todo el pulmón sin perder los ápices ni crear ruidos falsos

un mal contacto da → **Falsos ruidos**
diafragma mal adaptado o vello que roza; se evita con presión firme o vaselina
asegura el recorrido → Sentado, de arriba abajo y lado contra lado: así se recorre todo el pulmón sin perder los ápices ni crear ruidos falsos

2 · LO NORMAL: MURMULLO, BRONQUIAL Y RELACIÓN I/E

lo normal que se oye es el → **Murmullo vesicular** (F1)
nace en el alvéolo (la letra F): suave, toda la inspiración y el inicio de la espiración

baja en todo el tórax en el → **Disminuido en todo el tórax** (F1)
enfisema y obesidad (menos aire o más tejido interpuesto)
pesa antes de decidir → Antes de llamar patológico un murmullo bajo, descarta sus zonas fisiológicas; en el asma baja y se alarga la espiración

baja sin enfermedad en → **Baja sin ser enfermedad**
región precordial, proyección hepática, espacio de Traube, mamas y músculo hipertrófico
pesa antes de decidir → Antes de llamar patológico un murmullo bajo, descarta sus zonas fisiológicas; en el asma baja y se alarga la espiración

en laringe y tráquea oye la → **Respiración bronquial**
normal solo sobre laringe y tráquea; en otro sitio ya es patológica
pesa antes de decidir → Antes de llamar patológico un murmullo bajo, descarta sus zonas fisiológicas; en el asma baja y se alarga la espiración

su duración define la → **Relación inspiración/espiración**
normal 1:2 a 1:1,5; en asma y EPOC se alarga la espiración (apuntes 2018: 1:3; discrepancia dejada como tarea)
pesa antes de decidir → Antes de llamar patológico un murmullo bajo, descarta sus zonas fisiológicas; en el asma baja y se alarga la espiración

alarga la → Antes de llamar patológico un murmullo bajo, descarta sus zonas fisiológicas; en el asma baja y se alarga la espiración

3 · RUIDOS SECOS: EL CALIBRE DEL BRONQUIO

si algo estrecha el bronquio → **Estertores secos**
luz bronquial estrechada por espasmo, edema o secreción adherida

en bronquio grueso da → **Roncus**
graves, de bronquios gruesos cuyas paredes vibran; disminuyen o desaparecen con la tos
con la tos → Difusas: asma, EPOC, bronquitis aguda y asma cardíaca; si son localizadas, cuerpo extraño o tumor

en bronquio fino da → **Sibilancias** (F2)
agudas, de bronquios finos y bronquiolos terminales, más intensas en la espiración; no cambian con la tos
con la tos → Difusas: asma, EPOC, bronquitis aguda y asma cardíaca; si son localizadas, cuerpo extraño o tumor
si son difusas o localizadas → **Difusas**: asma, EPOC, bronquitis aguda y asma cardíaca; si son localizadas, cuerpo extraño o tumor (F3)
la excepción es la → **Excepción: bronquiectasias** (F3)
bronquio dilatado con broncorrea de 400-600 ml/día: dan subcrepitantes localizados y roncus

4 · RUIDOS HÚMEDOS Y FROTE PLEURAL

Estertores húmedos
aire que atraviesa líquido en bronquios o alvéolos

si hay líquido →
en el bronquiolo da → **Subcrepitantes**
burbujeo en bronquiolos; sí cambian con la tos → bronconeumonía, bronquiectasias
con la tos → **La tos separa**: cambian roncus y subcrepitantes (secreción móvil); no cambian sibilancias, crepitantes ni frote

en el alvéolo da → **Crepitantes**
alveolares, al final de la inspiración, como pisar nieve; no cambian con la tos → neumonía, edema pulmonar
con la tos → **La tos separa**: cambian roncus y subcrepitantes (secreción móvil); no cambian sibilancias, crepitantes ni frote

si se inflama la pleura → **Frote pleural** (F4)
cuero nuevo o madera seca, en ambos tiempos y en las axilas inferiores; aumenta al apretar el estetoscopio
con la tos → **La tos separa**: cambian roncus y subcrepitantes (secreción móvil); no cambian sibilancias, crepitantes ni frote
traduce una → **Pleuritis**: inflamación exudativa de las dos hojas pleurales

su causa cardinal es el → **La tos separa**: cambian roncus y subcrepitantes (secreción móvil); no cambian sibilancias, crepitantes ni frote

5 · LA VOZ: EL «33»

se completa con la → **Voz con «33»**
normal: sonido confuso y lejano; se evalúa cómo la transmite el tejido

sobre una condensación → **Broncofonía**
voz nítida sobre una condensación
se resume en la → La voz aumentada marca tejido denso o hueco; disminuida, derrame o atelectasia

sobre una caverna → **Pectoriloquia** (F5)
voz articulada y clara: signo de caverna (en voz alta si es grande y superficial)
se resume en la → La voz aumentada marca tejido denso o hueco; disminuida, derrame o atelectasia

sobre un derrame mediano → **Egofonía**
voz de cabra sobre un derrame de mediano volumen
se resume en la → La voz aumentada marca tejido denso o hueco; disminuida, derrame o atelectasia

6 · ASMA: POR QUÉ SE CIERRA EL BRONQUIO

Asma bronquial (síndrome de obstrucción bronquial)
estrechamiento difuso y reversible de los bronquiolos terminales

el bronquiolo es →
sobre un terreno → **Terreno alérgico** (F9)
predisposición genética mediada por IgE; el frío o el invierno lo desencadenan
desencadena → **Tres cambios a la vez**
edema de la mucosa, broncoespasmo e hipersecreción de moco espeso
pero es → El estrechamiento es reversible: lo distingue de la bronquiectasia
deja el → **Aire atrapado**
entra con facilidad pero sale con dificultad; espiración prolongada e hiperinsuflación

responde con → **Bronquiolo hiperreactivo** (F12)
se cierra con estímulos mínimos; la prueba de metacolina 🛍️ lo demuestra

se manifiesta con la →

7 · ASMA: EXAMEN, CASO Y EXÁMENES

se plantea con un →

Triada
tos, disnea espiratoria y sibilancias; esputo mucoide, blanco y espeso
al examinar → **Examen en el broncoespasmo** (F6)
tiraje; vibraciones normales o disminuidas; percusión normal o hipersonora; murmullo disminuido, roncus y sibilancias diseminados
da el → **Aire atrapado**
entra con facilidad pero sale con dificultad; espiración prolongada e hiperinsuflación
si es crónico, hay → **Tórax en tonel**
en formas crónicas o de larga evolución

Caso
mujer de 36 años, Cusco, crisis desde la niñez en invierno; 5 días de disnea y esputo mucoide; cianosis distal, tiraje, roncus y sibilancias en ambos campos

apoya el diagnóstico →
primero el → **Síndrómico** (F7)
obstrucción bronquial
luego el → **Presuntivo** (F8)
asma bronquial
y la causa → **Etiológico** (F9)
alérgico (IgE)
se estudia con → **Exámenes** (F10)
radiografía (hiperinsuflación), espirometría, gasometría u oximetría y hemograma

8 · SI LA CRISIS NO CEDE: COMPLICACIONES

si la crisis no cede → **Insuficiencia respiratoria aguda** (F11)
la crisis que no cede agota la ventilación: hipoxemia y acidosis
además → **Otras inmediatas**
neumotórax, arritmias por la acidosis y bronconeumonía
si se repite durante años → **Tardías**
aire atrapado e hipoxia sostenidos: enfisema
termina en → **Cor pulmonale crónico** (F11)
sobrecarga del corazón derecho a la larga

técnica · concepto · complicación · desenlace · signo · mecanismo · ejemplo · síndrome · causa · síntoma · diagnóstico · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.° # de la lámina

Fuente: Sotomayor, apuntes de Semiología Médica 2020, tema 7 (07d Auscultación pulmonar, 07f Síndromes bronquiales, 07g Exámenes) — teoría del docente; metacolina: 🛍️ literatura